

CAPÍTULO 11.1

Conceptos de Nefrología

PERFIL EUNACOM 1.06.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

SIADH — Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH

Fisiopatología

Exceso de ADH → **retención de agua libre** → dilución del sodio plasmático → **hiponatremia**.

Causas Claves (Trigger + Hiponatremia = SIADH)

TABLA 11.1.1: CATEGORÍA VS EJEMPLOS	
CATEGORÍA	EJEMPLOS
SNC	TEC, meningitis, ACV, encefalitis
Pulmonar	TBC, bronquiectasias, TEP, cáncer pulmonar, neumonía
Tumores	Oat cell (cáncer pulmón), páncreas, duodeno
Posquirúrgico	Dolor + opiáceos (complicación postoperatoria clásica)
Fármacos	Carbamazepina, antidepresivos, AINES

Diagnóstico

TABLA 11.1.2: CRITERIO VS VALOR	
CRITERIO	VALOR
Hiponatremia	Na ⁺ plasmático bajo
Osmolaridad urinaria	> 200 mOsm/kg (orinas concentradas a pesar de hiponatremia)
Orinas concentradas + sangre diluida	Hallazgo central → retención de agua libre confirmada

> El error clásico es asumir que basta con dar sal. **Las hiponatremias dependen del balance de AGUA, no de sodio.**

Clínica de la Hiponatremia

TABLA 11.1.3: NA+ VS SÍNTOMAS	
NA+	SÍNTOMAS
> 125	Asintomática
120-125	Náuseas, cefalea, malestar
< 120	Edema cerebral, convulsiones, coma

Tratamiento

TABLA 11.1.4: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Restricción de agua libre	≤ 800 mL/día (pilar fundamental)
Tratar la causa	Si es tratable (neumonía, etc.)
Furosemida	Apoyo: aumenta clearance de agua libre
Sal (tabletas)	Rol menor, solo si hay pérdida asociada a largo plazo

EUNACOM CRITERIOS

Nunca corregir la hiponatremia demasiado rápido → riesgo de mielinólisis pontina central (síndrome de desmielinización osmótica). Corrección máxima: **8-10 mEq/L por día**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años presenta edema de extremidades inferiores, orinas espumosas y exámenes que muestran proteinuria de 4.5 g/día, albúmina sérica de 2.8 g/dL, colesterol total de 320 mg/dL y sedimento urinario sin hematuria dismórfica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Conceptos de Nefrología. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Insuficiencia renal aguda: menos de 3 meses, potencialmente reversible. Crónica: más de 3 meses, generalmente irreversible.
- Proteinuria: mayor a 300 mg/día (índice P/C mayor a 0.3). Proteinuria nefrótica: mayor a 3 g/día (índice P/C mayor a 3).
- Microalbuminuria: mayor a 30 mg/día (relación A/C mayor a 0.03), marcador de nefropatía diabética inicial.
- Glomerulonefritis = hematuria dismórfica = acantocitos en sedimento urinario. Patognomónico.
- Glomerulonefritis rápidamente progresiva: clearance cae al menos 50% en menos de 3 meses.
- Síndrome nefrítico: tríada de hematuria + hipertensión + edema.
- Síndrome nefrótico: proteinuria nefrótica + edema + hipoalbuminemia + dislipidemia + lipiduria.
- Síndrome nefrótico impuro: nefrótico + elementos nefríticos (hematuria, HTA o falla renal).
- Síndrome riñón-pulmón: glomerulonefritis + compromiso pulmonar (vasculitis, Goodpasture, lupus).
- Nefritis intersticial: inflamación del intersticio y túbulos renales, NO del glomérulo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONCEPTOS DE NEFROLOGÍA)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años presenta edema de extremidades inferiores, orinas espumosas y exámenes que muestran proteinuria de 4.5 g/día, albúmina sérica de 2.8 g/dL, colesterol total de 320 mg/dL y sedimento urinario sin hematuria dismórfica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Síndrome nefrítico
- B) Síndrome nefrítico puro
- C) Síndrome nefrítico impuro
- D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
- E) Proteinuria en rango nefrótico sin síndrome nefrótico

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo patognomónico de glomerulonefritis en el sedimento urinario?

- A) Cilindros hialinos
- B) Leucocituria y bacteriuria
- C) Hematuria dismórfica o acantocitos
- D) Proteinuria mayor a 300 mg/día
- E) Cilindros granulosos

PREGUNTA 3

Paciente diabético tipo 2 de larga data presenta microalbuminuria de 45 mg/día con clearance de creatinina normal. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A) Es normal, no requiere seguimiento
- B) Tiene una insuficiencia renal crónica etapa 3
- C) Nefropatía diabética inicial con daño renal incipiente (ERC etapa 1)
- D) Síndrome nefrótico incipiente
- E) Glomerulonefritis diabética

RESUMEN: CONCEPTOS DE NEFROLOGÍA

Esta clase introductoria establece las definiciones fundamentales de nefrología que permiten comprender todas las patologías renales. Se define insuficiencia renal como caída del clearance de creatinina, diferenciando la aguda (menos de 3 meses, potencialmente reversible) de la crónica (más de 3 meses, generalmente irreversible). Se explican los conceptos de proteinuria (mayor a 300 mg/día o índice proteinuria/creatininuria mayor a 0.3), proteinuria en rango nefrótico (mayor a 3 g/día), síndrome nefrótico (proteinuria nefrótica más edema, orinas espumosas, hipoalbuminemia, dislipidemia) y microalbuminuria (mayor a 30 mg/día, marcador de nefropatía diabética inicial). Se diferencia la glomerulonefritis (inflamación del glomérulo con hematuria dismórfica/acantocitos), la glomerulonefritis rápidamente progresiva (clearance cae más del 50% en menos de 3 meses), el síndrome nefrítico (triada de hematuria, hipertensión y edema), el síndrome nefrótico impuro (nefrótico más elementos nefríticos), el síndrome riñón-pulmón y la nefritis intersticial.